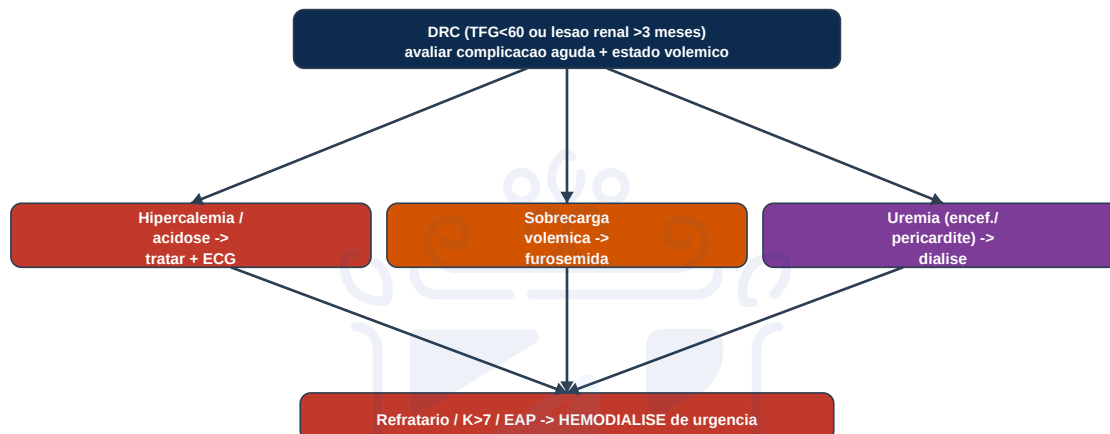


DOENÇA RENAL CRÔNICA — COMPLICAÇÕES NO PS

FLUXOGRAMA — DRC NO PS

DRC — TRATAR AS COMPLICAÇÕES AGUDAS



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Anormalidade de estrutura ou função renal por > 3 meses
- Critério: TFG < 60 mL/min/1,73m² (CKD-EPI 2021) OU albuminúria ≥ 30 mg/g OU outra lesão renal
- Principais etiologias: HAS, DM, doença renal policística (DRPAD), glomerulopatias
- No PS, o foco é tratar as COMPLICAÇÕES AGUDAS e reconhecer urgências dialíticas

QUANDO SUSPEITAR — SINTOMAS URÊMICOS E VOLEMIA

ANAMNESE E EXAME

- Sintomas urêmicos: náuseas/vômitos, anorexia, prurido, alteração do nível de consciência, sabor metálico
- Sobrecarga volêmica: dispneia, ortopneia, edema, turgência jugular, estertores
- Débito urinário (oligúria/anúria); exposições recentes (contraste, AINE, antibióticos)
- Exame: estado volêmico, ASTERIXIS, atrito pericárdico (pericardite urêmica), palidez (anemia)
- Buscar o fator de agudização (sepse, hipovolemia, nefrotóxico, obstrução)

EXAMES

SOLICITAR

- Função renal: ureia, creatinina, TFG estimada (CKD-EPI 2021)
- Eletrólitos: Na, K, Cl, Ca, fósforo, Mg; gasometria (acidose)
- Hemograma (anemia), urina I, relação albumina/creatinina, glicemia
- USG de rins e vias urinárias (tamanho renal, hidronefrose/obstrução)
- ECG: hipercalcemia (T apiculada, alargamento de QRS, bloqueios). Conforme clínica: PTH, vitamina D, sorologias

TRATAMENTO — HIPERCALEMIA

Rx K > 5,5 (estabilizar -> redistribuir -> eliminar)

Estabilização cardíaca (K > 6,5 ou alteração no ECG): Gluconato de cálcio 10% 10-20 mL EV em 5-20 min
Redistribuição: Insulina regular 10 UI EV + glicose 50% 100 mL; Salbutamol inalatório 6 puffs
Bicarbonato de sódio 8,4% 50-100 mEq EV (se acidose associada)
Eliminação: Furosemida 40-80 mg EV (se diurese preservada); resina (poliestireno sulfonato)
Ciclossilicato de zircônio (Lokelma) 10 g VO 3x/dia até 48h, depois 5-10 g/dia
HEMODIÁLISE de urgência se refratário ou K > 7,0

TRATAMENTO — ACIDOSE, VOLEMIA, ANEMIA, UREMIA

Rx ACIDOSE / SOBRECARGA

Acidose ($\text{HCO}_3^- < 18$): Bicarbonato 8,4% 50-100 mEq EV
Meta HCO_3^- 18-22 (não ultrapassar a normalidade)
Sobrecarga: Furosemida 40-100 mg EV (ou BIC contínua se refratário)
EAP refratário -> hemodiálise de urgência
Suspender AINE e nefrotóxicos

Rx ANEMIA / SINTOMAS URÊMICOS

Anemia: investigar/tratar ferropenia (sulfato ferroso ou ferro EV)
Transfundir se Hb < 7 ou sintomático; ESA via nefrologia
Sintomas urêmicos: antieméticos (metoclopramida/ondansetrona)
Diálise de urgência se: encefalopatia urêmica, pericardite urêmica, sintomas refratários ao tratamento clínico

CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO / URGÊNCIA DIALÍTICA

INTERNAR SE

- Hipercalemia grave (K > 6,5) ou refratária; acidose grave ($\text{pH} < 7,2$ ou $\text{HCO}_3^- < 15$)
- Sobrecarga volêmica com edema pulmonar; sintomas urêmicos graves (encefalopatia, pericardite, pleurite)
- Anúria/oligúria persistente; instabilidade; necessidade de hemodiálise de urgência
- Declínio agudo da função renal (> 25% da TFG basal); DRC G4-G5 com complicações não controladas
- Mnemônico de diálise de urgência (AEIOU): Acidose, Eletrólitos (K), Intoxicação, Overload (volume), Uremia

ALTA E ORIENTAÇÕES

ALTA SE

- ☐ Estabilidade hemodinâmica; K $\leq$ 5,5; $\text{HCO}_3^- > 18$; sem sobrecarga; sem sintomas urêmicos
- ☐ Dieta: restrição de sódio (<2g/dia), de potássio (se hiperK) e de fósforo; proteína ~0,8 g/kg/dia
- ☐ Suspender AINE/nefrotóxicos; evitar contraste sem orientação; iSGLT2 conforme indicação (TFG > 20, albuminúria)
- ☐ Monitorar peso e PA em casa; controle glicêmico (HbA1c $\leq$ 7% se DM)
- ☐ Retorno: dispneia/edema progressivo, queda do volume urinário, vômitos persistentes, confusão, dor torácica

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- DRC estágio ____ (pré-dialítico/dialítico) agudizada por ____ (sepse/hipovolemia/contraste/obstrução).
- K ____; HCO_3 ____; creatinina ____; débito urinário ____; acesso vascular (se dialítico): ____.
- Condutas: gluconato de cálcio / insulina+glicose / furosemida / bicarbonato. Evitar punção no membro da fístula!
- Solicito hemodiálise de urgência / avaliação nefrológica / manejo de hipercalemia refratária.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com DRC G5, K 7,2 mEq/L e onda T apiculada no ECG. Qual a PRIMEIRA medida?

- A) Resina de troca por via oral isoladamente
- B) Gluconato de cálcio EV para estabilização da membrana miocárdica
- C) Furosemida em dose alta isolada
- D) Bicarbonato oral
- E) Aguardar a hemodiálise sem medidas

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Quais são indicações de hemodiálise de urgência (mnemônico AEIOU)?

- A) Apenas creatinina elevada
- B) Acidose grave, distúrbios eletrolíticos (hipercalcemia) refratários, intoxicações, sobrecarga volêmica e uremia (encefalopatia/pericardite)
- C) Apenas anemia
- D) Hipertensão controlada
- E) Proteinúria isolada

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual conduta medicamentosa deve ser SUSPENSA no paciente com DRC agudizada?

- A) Bicarbonato de sódio
- B) AINES e demais nefrotóxicos
- C) Sulfato ferroso
- D) Furosemida
- E) Quelante de potássio

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual achado indica pericardite urêmica e necessidade de diálise?

- A) Sopro sistólico
- B) Atrito pericárdico em paciente urêmico
- C) Edema de membros inferiores isolado
- D) Hipertensão leve
- E) Anemia ferropriva

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

No acesso venoso de paciente com DRC dialítico, qual cuidado é essencial?

- A) Puncionar preferencialmente o membro da fístula arteriovenosa
- B) Evitar puncionar o membro da fístula arteriovenosa
- C) Usar sempre acesso intraósseo
- D) Não obter acesso venoso
- E) Puncionar a fístula para infusão de medicações

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Com $K > 6,5$ e alteração no ECG, a primeira medida é o gluconato de cálcio EV (estabiliza a membrana miocárdica, protegendo contra arritmia), seguido de insulina+glicose e salbutamol (redistribuição) e medidas de eliminação/diálise.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

As indicações de diálise de urgência (AEIOU): Acidose refratária, Eletrólitos (hipercalcemia refratária), Intoxicações dialisáveis, Overload (sobrecarga volêmica/EAP refratário) e Uremia (encefalopatia/pericardite).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

AINES e demais nefrotóxicos devem ser suspensos na DRC agudizada, pois agravam a lesão renal. Mantêm-se as medidas de suporte (bicarbonato, furosemida, quelantes, ferro) conforme a indicação.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O atrito pericárdico em paciente urêmico indica pericardite urêmica — uma das indicações de diálise de urgência (componente 'U' do AEIOU), pelo risco de tamponamento.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Deve-se EVITAR puncionar o membro da fístula arteriovenosa (risco de trombose/infecção do acesso vital para a diálise). Usa-se o membro contralateral ou outro acesso.

SM24
Suporte ao Plantão Médico